認定結果(テスト用設定)

テスト用架空事例

要介護度	要介護3
認定日	令和8年11月9日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年10月1日～令和9年3月31日(6か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年10月 日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	区分変更申請(前回:要介護1)		
対象者氏名	小田 茂 (おだ しげる)	性別	男
生年月日	昭和17年(1942年)11月8日	年齢	84歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

通所介護 週1回(入浴あり)。福祉用具・住宅改修の利用なし。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	妻(80歳)と二人暮らし。妻は腰痛があり整形外科に通院中。夜間に何度も起こされ、睡眠が十分にとれていない。長男(55歳)は同市内在住で、週末に訪問して入浴や通院を手伝う。長女(52歳)は県外在住。
居住環境	持ち家の分譲マンション3階(エレベーターあり)。室内はバリアフリーだが、トイレ・浴室に手すりがない。寝室はベッドではなく布団。
使用している機器等	なし(歩く時は家具や妻の腕につかまる)。
生活歴	元中学校の理科教師。退職後は地域の郷土史研究会で活動していた。几帳面で穏やかな性格だったが、半年前から急に症状が進んだ。
本人・家族の主訴	本人(調子のよい時):「家がいい。ばあさんには苦労をかけとる。」 妻:「家で看てあげたいけれど、夜に何度も起こされて、もう体がもたない。少し休める時間がほしい。」 長男:「週末は手伝える。母が先に倒れないか心配。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない)　左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	(ない)　肩関節　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-4 起き上がり	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-5 座位保持	できる　(自分の手で支えればできる)　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる　(何か支えがあればできる)　できない
1-7 歩行	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる　(できない)
1-10 洗身	介助されていない　一部介助　(全介助)　行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助　(全介助)
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない))　約1m離れた視力確認表の図が見える　目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない　見えているのか判断不能
1-13 聴力	普通　(普通の声がやっと聞き取れる)　かなり大きな声なら何とか聞き取れる　ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
2-2 移動	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
2-3 えん下	できる　(見守り等)　できない
2-4 食事摂取	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
2-5 排尿	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
2-6 排便	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
2-7 口腔清潔	介助されていない　(一部介助)　全介助
2-8 洗顔	介助されていない　(一部介助)　全介助
2-9 整髪	介助されていない　(一部介助)　全介助
2-10 上衣の着脱	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
2-12 外出頻度	(週1回以上)　月1回以上　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	調査対象者が意思を他者に伝達できる　(ときどき伝達できる)　ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	できる　(できない)
3-3 生年月日や年齢を言う	できる　(できない)
3-4 短期記憶	できる　(できない)
3-5 自分の名前を言う	(できる)　できない
3-6 今の季節を理解する	できる　(できない)
3-7 場所の理解	できる　(できない)

3-8 徘徊	(ない) ときどきある ある
3-9 外出すると戻れない	(ない) ときどきある ある
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	ない (ときどきある) ある
4-2 作話	ない (ときどきある) ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	ない (ときどきある) ある
4-4 昼夜の逆転がある	ない ときどきある (ある)
4-5 しつこく同じ話をする	ない (ときどきある) ある
4-6 大声をだす	ない (ときどきある) ある
4-7 介護に抵抗する	ない (ときどきある) ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない) ときどきある ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない) ときどきある ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない) ときどきある ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない) ときどきある ある
4-12 ひどい物忘れ	ない ときどきある (ある)
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	ない ときどきある (ある)
4-14 自分勝手に行動する	(ない) ときどきある ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	ない (ときどきある) ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない 一部介助 (全介助)
5-2 金銭の管理	介助されていない 一部介助 (全介助)
5-3 日常の意思決定	できる(特別な場合でもできる) 特別な場合を除いてできる (日常的に困難) できない
5-4 集団への不適応	(ない) ときどきある ある
5-5 買い物	介助されていない 見守り等 一部介助 (全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない 見守り等 一部介助 (全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理 □中心静脈栄養 □透析 □ストーマ(人工肛門)の処置 □酸素療法 □レスピレーター(人工呼吸器) □気管切開の処置 □疼痛の看護 □経管栄養 □モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) □じょくそうの処置 □カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立 J1 J2 A1 (A2) B1 B2 C1 C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb (Ⅲa) Ⅲb Ⅳ M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-3・1-4 布団の横に置いたタンスにつかまって行う。体のこわばりが強い朝は時間がかかり、妻が背中を支えることがある。 1-5 座っていると体が左に傾き、手で支えている。 1-7 小刻みで、歩き始めや方向転換の時に足がすくむ。家具や妻の腕につかまって歩く。この3か月で室内での転倒が4回(骨折なし)。 1-10 週1回は通所介護で、週1回は長男が自宅で洗っている。本人は洗う動作がほとんどできず、全介助。 1-13 普通の声では聞き取りにくく、少し大きな声で話すと聞き取れる。
第2群 生活機能	2-1 布団からの立ち上がり・トイレの便座への移乗は、つかまって自分で行うが、ふらつきが強いため妻が付き添っている。 2-2 調子のよい時は家具につかまって歩くが、1日の大半は妻が腕を支えて移動している。頻度の多い方で一部介助とした。 2-3・2-4 食事中にむせることが1日に数回ある。妻が一口量を声かけしながら見守っている。 2-5 夜間に2〜3回トイレに起き、間に合わず失禁することが週に3〜4回ある。妻がリハビリパンツの交換と後始末をしている。 2-6 便秘があり下剤を内服。排便後の拭き取りが不十分なため、妻が確認している。 2-10・2-11 着衣の袖通し・ボタン・ズボンの上げ下げを妻が介助している。 2-12 週1回の通所介護と、月1回の神経内科への通院(長男の車)。
第3群 認知機能	3-1 調子のよい時は会話が成り立つが、ぼんやりしている時は質問への答えが返ってこない。調査中も途中から反応が乏しくなった。 3-3 年齢を「70歳」と答えた。 3-6・3-7 季節を答えられず、場所を「学校」と答えた。
第4群 精神・行動障害	4-1 「知らない男が家に入ってきて物を盗っていく」と言うことが週1回程度ある。 4-2 「さっき息子と釣りに行った」など、実際にはないことを話す(妻より)。 4-4 昼間はうとうとしていることが多く、夜中に目を覚まして動き出すことがほぼ毎晩ある。 4-6 夜間、幻視に向かって大きな声で話しかけることが週に2〜3回ある。 4-7 入浴や着替えの時に、手を払いのけて嫌がることが週1回程度ある。 4-13 部屋の隅に「子どもがいる」と言って話しかけることがほぼ毎日ある。 4-15 調子の悪い時は話の筋が通らず、会話にならない。
第5群 社会生活への適応	5-1 薬の数が多く(1日5回の服用時間がある)、妻が1回ずつ口元まで運んで飲ませている。 5-2 金銭の管理はすべて妻が行っている。 5-3 服を選ぶことなど日常のことも、自分で決めることが難しくなっている。 5-5・5-6 買物・調理はすべて妻が行っている。
特別な医療	該当なし。

主治医意見書

テスト用架空事例

申請者	小田 茂　(男・84歳)　医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. レビー小体型認知症	約2年前
2. 前立腺肥大症	約10年前
3. 起立性低血圧	約1年前

(2)症状としての安定性	不安定
(3)経過及び治療内容	2年前に幻視と物忘れで受診し、レビー小体型認知症と診断。半年前からパーキンソン症状(筋固縮・すくみ足)と症状の日内変動が強まり、転倒を繰り返している。抗精神病薬に過敏性があり、薬の調整は慎重に行う必要がある。起立性低血圧があり、立ち上がり時のふらつきに注意。便秘あり。 投薬:抗認知症薬、抗パーキンソン病薬、前立腺肥大症治療薬、下剤、昇圧薬。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):A2　認知症高齢者の日常生活自立度:IIIa
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題あり/日常の意思決定:判断できない(調子の悪い時)〜いくらか困難/意思の伝達:具体的要求に限られる
(3)認知症の行動・心理症状	幻視・幻聴、妄想、昼夜逆転、大声、介護への抵抗
(4)その他の精神・神経症状	症状の日内変動(意識レベルの変動)
(5)身体の状態	利き腕:右/身長163cm・体重54kg(半年で4kg減)/筋固縮あり/すくみ足あり/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:介助があればしている/車いす:主に他人が操作(通院時)/歩行補助具:なし
(2)栄養・食生活	食事行為:何とか自分で食べられる/栄養状態:やや不良(体重減少)/留意点:むせに注意、一口量を少なく
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	転倒・骨折、摂食・嚥下機能低下、低栄養、誤嚥性肺炎、昼夜逆転 → 転倒予防の環境整備、食事形態の工夫、服薬管理と症状の観察
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	不明
(5)医学的管理の必要性	訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	血圧:起立性低血圧に注意。立ち上がりはゆっくり。嚥下:誤嚥に注意、食事形態の工夫を。移動:すくみ足による転倒に注意。その他:新たな薬は主治医に相談のこと(薬剤過敏性)。
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

主介護者である妻の疲労が強い。介護負担の軽減(短期入所などの利用)が必要。症状の変化は早めに連絡を。